

Twój pełny raport PEWA™

Typ: Analityk-Przyjaciel (AP)

Supermoc — precyzja + ciepło

racjonalna troska

Sekcja 1 — Kim jesteś (profil rozszerzony)

Twój DOMINUJĄCY archetyp to **Analityk**, z silnym wspierającym **Przyjacielem**. Precyzja + ciepło. Wiarygodność + bezpieczeństwo. Różnisz się od czystego Analityka tym, że *po* przekazaniu danych potrafisz spojrzeć pacjentowi w oczy i powiedzieć „rozumiem że to dużo. Mamy czas”. Różnisz się od czystego Przyjaciela tym, że *przed* wsparciem emocjonalnym dajesz konkret, na którym pacjent może się oprzeć.

W praktyce: Twoja wizyta wygląda tak — najpierw analiza i prezentacja danych (Analityk), potem moment ciepła i upewnienia że pacjent zrozumiał (Przyjaciel). To rzadkie, bo Analitycy często „rzucają fakty i wychodzą”, a Ty zostajesz.

Supermoc w jednym zdaniu: *Dajesz pacjentowi wiarygodność lekarza i obecność człowieka — w jednej osobie.*

Sekcja 2 — Twoja sygnatura komunikacyjna

Tempo równe. Pauzy długie ale ciepłe (nie chłodne). Łączysz „dane pokazują...” z „rozumiem”. Pacjent czuje że jest u eksperta, który jednak go widzi jako człowieka, nie przypadek.

5 zdań które wypowiadasz częściej: 1. „Według badań..., więc to dla Pani znaczy że...” 2. „Daję Pani 48h. Wiem że to dużo informacji.” 3. „Jakie ma Pan pytania? Mamy czas.” 4. „Sprawdzę to i wracam z konkretem. Najpóźniej do jutra.” 5. „Rozumiem że to dla Pana trudne. Pomogę przejść przez to krok po kroku.”

Twoja postawa: spokojna, ciepły kontakt wzrokowy, gestykulacja minimalna, notatki podczas rozmowy.

Sekcja 3 — Mocne strony rozszerzone

1. Pacjent Przyjaciel + Analityk → idealna chemia z obydwojoma

Twoja precyzja uspokaja Analityka, Twoje ciepło otwiera Przyjaciela. **Użyj tego:** Ty obsługuj „najmilszych” i „najmądrzejszych” w zespole.

2. Trudne diagnozy podawane z troską

Łączysz „dane mówią X” z „rozumiem że to trudne”. **Użyj tego:** wszystkie diagnozy onkologiczne, neurologiczne, genetyczne — przez Ciebie.

3. Drugą opinią DLA pacjentów strachliwych

Pacjent chce sprawdzenia ALE boi się ostrego lekarza. Ty łączysz weryfikację z empatią. **Użyj tego:** zostań „lekarzem drugiej opinii” w okolicy.

4. Mistrzowska edukacja długoterminowa

Pacjenci z chorobami przewlekłymi (cukrzyca, nadciśnienie, paradontoza) wymagają i danych, i wsparcia, i czasu. **Użyj tego:** program „rocznego prowadzenia” pacjentów z chorobą przewlekłą.

5. Naturalna mentorka młodszych

Łączysz cierpliwość (Przyjaciel) z merytoryką (Analityk). **Użyj tego:** prowadź szkolenia dla studentów, młodszych lekarzy.

6. Świetna w testach i diagnostyce

Twoja precyzja + cierpliwość do tłumaczenia wyniku = idealny diagnosta. **Użyj tego:** specjalizuj się w diagnostyce złożonej.

Sekcja 4 — Naturalne wyzwania + pierwsza pomoc

Kombinacja Analityk-dominacja + Przyjaciel wsparcie ma 2 napięcia: chcesz dane wcześniej, czujesz że pacjent potrzebuje ciepła wcześniej.

1. Chłodny start, ciepły koniec

Sygnal wczesny: pacjent w pierwszych 5 minutach czuje Cię „odległo”. **Pomoc 60 sek:** pierwsze 30 sek wizyty — TYLKO ciepło. „Dzień dobry, dziękuję

że Pani przyszła. Zanim zaczniemy, jak się Pani dziś czuje?” **Plan długofalowy:** ćwicz „warmup minute” — pierwsza minuta każdej wizyty.

2. Nadmierna analiza zamiast działania

Sygnal: zbierasz dane 3 tygodnie, decyzji brak. **Pomoc:** zasada „80% wystarczy” dla decyzji odwracalnych. **Plan długofalowy:** masz „budget decyzyjny” — 1 decyzja typu „analityczna” tygodniowo, reszta na intuicji.

3. Trudność z pacjentem Wódz

Sygnal: Wódz Cię „dopytuje”, Ty się chowasz w dane. **Pomoc:** dla Wodzów — „3 opcje: A, B, C. Rekomenduję B. Pana decyzja.”

4. Trudność z pacjentem Entuzjastą

Sygnal: jego tempo Cię męczy, jego obietnice Cię niepokoją. **Pomoc:** spis po wizycie podsumowanie i wyślij SMS-em. Entuzjasta i tak zapomni.

5. Praca długimi godzinami

Sygnal: soboty w gabinecie, niedziele z dokumentacją. **Pomoc:** asystentka A do dokumentacji. Ty już zrobiłeś najtrudniejsze. **Plan długofalowy:** wprowadź zasadę „piątek 17:00 koniec”. Bezwzględnie.

6. Wycofanie z konfliktów zespołowych

Sygnal: napięcie w zespole, Ty stajesz po stronie „analizy” zamiast po stronie ludzi. **Pomoc:** w konfliktach — pierwsze pytanie „co czujesz?”, dopiero potem „jakie fakty?”.

Sekcja 5 — Pacjenci których rozumiesz

Test PEWA jest uniwersalny — dla lekarzy POZ, specjalistów, dentystów, pielęgniarek, asystentek, recepcjonistek. **Dentyści** mają tu dodatkowy bonus: 800 testów Michała Katarzyńskiego w polskich praktykach stomatologicznych potwierdziło te same 4 typy z bardzo konkretnymi sygnałami (źródło: ebook „Jak zaspokoić 7 podstawowych potrzeb pacjentów stomatologicznych”, 2017).

PRZYJACIEL — relacyjny ciepły

Słowa: bliskość, ciepło, opieka, bezpiecznie, czuje. **Motywatory:** bezpieczeństwo, empatia, dozowanie. **Nie lubi:** nagłych zmian, twardości. **Stomatologia:** najbardziej lojalny typ; nie mów „Proszę się nie obawiać” → mów „Może Pan być spokojny — mamy bezpieczne, komfortowe znieczulenia”.

ENTUZJASTA — emocjonalny ekstrawertyk

Słowa: *fantastycznie, super, rewelacja, efektowny*. **Motywatory:** atmosfera, komplementy, wizualizacja. **Nie lubi:** odrzucenia, długiego leczenia bez efektu. **Stomatologia:** szybko skraca dystans (uścisk, poklepywanie), słowotok; pokaż zdjęcie efektu PRZED rozmową; spis harmonogram (sam zapomni).

WÓDZ — racjonalny ekstrawertyk

Słowa: *zdecydowanie, natychmiast, najlepiej, strategia*. **Motywatory:** jakość, kontrola, „naj...”, dane. **Nie lubi:** utraty kontroli, spóźnień, lekceważenia. **Stomatologia:** 80% szefów Fortune 500 = Wodzowie; najmniej lojalny, łatwo zostawia opinie; spóźnienia = traci pacjenta na zawsze.

ANALITYK — racjonalny introwertyk

Słowa: *dokładnie, dane, krok po kroku, jakość*. **Motywatory:** precyzja, czas bez presji, dużo informacji. **Nie lubi:** pośpiechu, chaosu, braku informacji. **Stomatologia:** sprawdził Twoją stronę PRZED wizytą; „*Muszę się zastanowić*” = normalne, nie odmowa; lubi schematy i mikroskop.

Pełna typologia z konkretnymi zdaniami DO i NIE-DO: dokument
PEWA-typologia-pacjentow-z-ebooka.pdf (osobny załącznik).

Sekcja 6 — Plan 30 dni

Tydzień 1: Czytasz raporty obydwu czystych archetypów (osobne PDF: raport-A.pdf i raport-P.pdf). Zaznaczasz w każdym 3 rzeczy które są ZGODNE z Tobą i 1 która NIE.

Tydzień 2: Wybierasz 1 supermoc z każdego archetypu (razem 2) i celowo używasz ich w 5 sytuacjach każdego dnia. Notujesz reakcję pacjentów.

Tydzień 3: Wybierasz 1 wyzwanie z każdego archetypu (razem 2) i robisz „pierwszą pomoc” za każdym razem gdy je wykryjesz. Notujesz częstotliwość.

Tydzień 4: Bilans. Co działa, co nie. Wprowadzasz 1 stałą zmianę w gabinecie (np. „warmup minute” przed każdą wizytą emocjonalnego pacjenta).

Sekcja 7 — Plan 90 dni

Miesiąc 1: Świadomość. Rozumiesz swoją kombinację, wiesz kiedy która część dominuje (sytuacje stresowe vs. komfortowe).

Miesiąc 2: Zespół. Wyjaśniasz asystentce/recepcjonistce/wspólnikowi Twój typ. Ustalacie wspólny język: kiedy ja jestem w trybie A, kiedy w trybie P, jak mnie wesprzeć.

Miesiąc 3: Pacjenci. Wprowadzasz rutynę „rozpoznanie typu pacjenta w 30 sekund” (z PEWA-typologia-pacjentow-z-ebooka.pdf). Po 3 miesiącach masz 90 nowych obserwacji = wiarygodne dane o sobie.

Sekcja 8 — Materiały dodatkowe

- **PEWA-raport-A.pdf** — pełny opis archetypu Analitik (Twoja DOMINUJĄCA część)
- **PEWA-raport-P.pdf** — pełny opis archetypu Przyjaciela (Twoja WSPIERAJĄCA część)
- **PEWA-typologia-pacjentow-z-ebooka.pdf** — typologia 4 typów pacjentów (uniwersalna + stomatologia)
- Webinar „Jak prowadzić rozmowę z trudnym pacjentem” (testomnia.pl/webinary — wkrótce)

Sekcja 9 — Vs populacja

W próbie 800 testów (Michał Katarzyński, polskie praktyki stomatologiczne) i rozszerzonych badaniach DOP: - ~**14% populacji** ma profil mieszany typu AP (Ty) - W grupach zawodowych: **farmaceuci ~24%, diagności ~18%, endodonci ~14%** - Stosunek dominacji A:P w Twoim wyniku jest niewielki — oznacza to że potrafisz przełączać się między trybami świadomie. Większość ludzi nie potrafi.

Sekcja 10 — Co dalej

Twój profil mieszany AP to dobra wiadomość: dwie supermoce zamiast jednej. Zła wiadomość: dwa zestawy wyzwań do ogarnięcia.

Jeśli prowadzisz zespół — opowiedz im o swoim typie. Zrozumią dlaczego raz jesteś w trybie Analitik, a raz w trybie Przyjaciela. Przestaną się tym dziwić.

Jeśli leczysz pacjentów — przeczytaj PEWA-typologia-pacjentow-z-ebooka.pdf przed jutrzejszym dniem. Po 1 tygodniu zaczniesz widzieć typy pacjentów intuicyjnie.

© 2026 testomnia.pl · Excellent Patient Service Sp. z o.o. · Model PEWA™
Materiały: 14 lat doświadczenia, 6 000 testów, 7 narzędzi PEWA, model PEWA™ — autorska metodologia Michała Katarzyńskiego (oparta na 800 testach z 2017 r.)